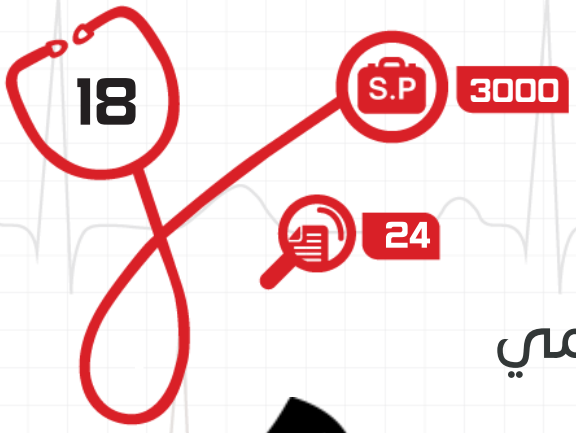



# فحص الجهاز الهضمي

1 د. أنس زكية

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

## المهارات السريرية | Clinical Skills

13/11/2024

مدققة Medicine

## السلام عليكم

بعد أن أنهينا المحطة القلبية، نعاود الإبحار معكم من جديد برحلة ممتعة إلى عالم الهضم، لنتعرف على مكنوناته وما يخبئه لنا من دلالات مهمّة توجهنا للتشخيص الصّحيح والعلاج المناسب، لذلك يسرّنا أن نفتتح معكم أولى محاضرات جهاز الهضم، والتي سنتحدث بها عن مقاربة مريض الهضم وفحص الجهاز الهضمي

متمنين أن نكون قد وفقنا في تقديمها لكم بالشكل الأمثل

## الفهرس


| الفقرة | الصفحة |
|---|---|
| الاستجواب | 2 |
| الفحص السريري | 9 |
| الفحوص المتممة | 23 |
| حلات سريرية | 24 |




# مقدمة

## إن مقاربة أي مريض تعتمد بشكل عام على ثلاث مراحل:

| الاستجواب | الفحص السريري | الفحوص المتمّمة |
|---|---|---|

يدلنا **الاستجواب** و**الفحص السريري** إلى **تشخيص واحد** أو **عدة تشاخيص تفريقيّة**، بينما نقوم **بالفحوص المتمّمة** (إيكو البطن والتنظير) **لتمييز التشاخيص التفريقيّة عن بعضها والوصول للتشخيص المناسب**، وذلك حسب حالة كل مريض.

## أمثلة:

- مريض لديه ألم في المراق الأيمن منتشر للكتف ← نفكر أولاً بوجود حصيات صفراوية.
- مريض لديه نزيف هضمي سفلي وبالفحص لم نلحظ شيئاً ← أول استقصاء يجب إجراؤه هو تنظير هضمي سفلي.
- مريض يرقان ولديه ألم في المراق الأيمن من ثلاثة أيام ← أول استقصاء هو الإيكو حيث نلاحظ توسع في القناة الجامعة والفحص المتمم الثاني هو ERCP[1].

**العرض**: هو الشكوى التي يأتي بها المريض، مثلاً يأتي المريض بشكوى الإسهال

**العلامة**: هي ما يكشفه الطبيب بالفحص السريري، فلن يأتي المريض يشكو من كبر طحاله

# الاستجواب

- يكون بجمع المعلومات المختلفة من المريض، والتي تهمّنا في التشخيص.
- **نراعي في الاستجواب عدة نقاط:**

1. **لغة** الطبيب والمريض واحدة، حيث يحاول الطبيب قدر الإمكان التحدث بلغة مفهومة وواضحة بالنسبة للمريض (أي لا يتحدث بطريقة علمية بحتة).
2. أن تكون **أسئلة الطبيب** للمريض محددة وموجهة للشكاية، حيث لا ندع المريض يسترسل في الكلام.
3. **عدم الايحاء للمريض بالأعراض** (بعض الأشخاص يجيبوا بنعم على أي سؤال) لذلك يجب أن نذكر عدة أعراض مثل: هل تشعر بألم بطني، إقياء، إسهال، ..... والعرض الذي يشعر به المريض بشكل أكبر يذكره ويُشير إليه.

[1] Endoscopic retrograde cholangiopancreatography.

## ↙ يتضمن الاستجواب:

### هوية المريض

#### اسم المريض.

#### جنس المريض:

- حيث أن بعض الحالات تصيب الذكور دون الإناث أو العكس؛ مثلاً:
  - مريضة لديها ألم بطني وغثيان وإقياء مع انقطاع الدورة الطمثية لعدة أشهر ← يمكن أن يكون حمل.
  - مريض ذكر أنَّ لديه آلام في البطن مع إقياء ← يمكن أن يكون تناذر قرحي.
  - مريض عمره 60 سنة لديه عسر بول مفاجئ أو متقطع ← نفكر في ضخامة البروستات.

### العمر

- أيضاً مهم في الاستجواب والتشخيص؛ مثلاً:
  - مريض كبير في السن لديه عسرة بلع مترقية ← نفكر بسرطان المريء حتى يثبت العكس.
  - طفل صغير لديه نفس الأعراض ← يمكن أن يكون اضطراب مريء حركي.
  - مريض عمره 65 سنة لديه إمساك مفاجئ ← يكون السبب سرطان كولون حتى يثبت العكس.

### الحالة الاجتماعية

- متزوج أو لا، وإذا لديه أولاد.

### العمل

#### 1. الإصابات المهنية:

- الأشخاص العاملين في معامل الإسمنت والنسيج يمكن أن يصابوا بتليف رئة أو ذات رئة.
- العاملين في صناعة البطاريات والمطابع يمكن أن يصابوا بالتسمم بالرصاص.

#### 2. مراعاة الإجهاد والضغط النفسي المرافق للعمل:

- حيث أن 60% من حالات الاضطرابات الهضمية الحركية كتشنج الكولون تكون بسبب نفسي Stress.

#### 3. التعرض لبعض المواد ذات السمية الكبدية.

#### 4. التعامل مع الحيوانات (مما يسبب كيسات مائية).

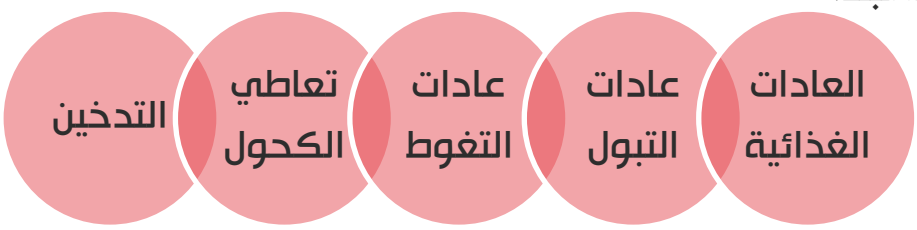
## السكن

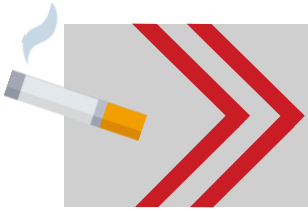
- مهم في التوجه للتشخيص فهناك مناطق موبوءة بأمراض معينة أكثر من غيرها، كما نراعي أيضاً أن المريض قد يكون مسافر من منطقة ما؛ مثلاً:
  - مريض جاء من السودان، والآن يشعر بحرارة بشكل ذرى (أي حرارة متموجة) مع آلام مفاصل وضخامات حشوية ← هنا يجب التفكير بالملاريا (فتلك المنطقة موبوءة بها).
  - قال لك المريض "بعد أن نزلت من الطائرة بيوم وجدت وذمة على قدمي اليمنى مع احمرار"، عندها يجب أولاً التفكير بالخثار الوريدي العميق DVT.
  - مريض من منطقة نائية يعاني من ألم بطني وترفع حروري ولديه حبن وذلك من فترة شهرين إلى ثلاثة ← يجب أن نفكر بالسل في البريتوان.
  - أما إذا كان المريض من مناطق ليست نائية ← يمكن أن نفكر بتشاخيص أخرى غير السل.
  - إذا كان لدى المريض ضخامة كبدية وكيسات على الكبد، يجب أن نسأله إذا كان يعيش في بيئة ريفية أو لديه تعامل مع الحيوانات.

## السؤال عن السوابق

### 7. العادات والغرائز (السوابق الشخصية):

- ويندرج تحت هذا البند:



التدخين يكون عامل مؤهب لكثير من الأورام ليس فقط في الجهاز التنفسي وأيضًا في المريء والبنكرياس، كما أنه يؤخر شفاء القرحة ويضعف المصرة المريئية السفلية

- أمثلة:
  - إذا جاء مريض بقصة التهاب بنكرياس ولديه عادة تناول الكحول، فالمرجح أكثر هو أن يكون سبب الالتهاب **كحولي** (التهاب بنكرياس كحولي).
  - أما إذا كان المريض لا يتناول الكحول فالاحتمال الممكن هو **الحصيات الصفراوية**، والتدبير يختلف بكل حالة.
  - المريض غير الكحولي يكون لديه **تناذر صفراوي**؛ مثلاً ألم بالمراق الأيمن (يتحرض بعد وجبة دسمة لنصف ساعة ثم يتراجع بشكل عفوي).

- إذا جاء مريض بحالة إقياءات وإسهالات[2] ← في حال كان يتناول الكحول فهو **التهاب معدة**[3]، بمجرد إعطاءه سيروماتٍ مع الـB6 (بيروكسيدين) فتتحسن حالة اعتلال الأمعاء أو المعدة.
- القرحة تأتي ليلاً بسبب زيادة إفراز الحمض ليلاً أثناء النوم، لذلك **يشتد الألم المرافق للقرحة ليلاً**.

أشيع سبب لليرقان الانسدادي هو الكحول أو الحصيات الصفراوية.

**ملاحظة**

لا يجب أن نسقط عاداتنا الشخصية على المريض ونسلّم أنه يتبعها؛ فمثلاً إذا جاء مريض بقصة ألم شرسوفي في الليل فإن أول مانفكر به هو القرحة باعتبار أن الألم يأتي على معدة فارغة ويوقظ المريض من النوم (وهنا سلّمنا أن المريض يتبع نظاماً غذائياً يتناول بموجبه غذاءه وقت الظهيرة مثل كل الناس)، ولكن عندما سألنا المريض عن مهنته فأجابنا بأنه يعمل حارس ليلي، وبالتالي الألم يأتي أثناء عمل المعدة (لأنه مستيقظ ليلاً ونائم نهاراً)، فيجب أن نبحث عن تشخيص آخر.

## 2. السوابق المرضية:

- وخاصة الأورام؛ فمثلاً:
  - في حالة مريض لديه حبن، أول ما نفكر به هو حدوث **انتقالات إلى البريتوان**.
  - مريض لديه إصابة بالتهاب الكبد منذ عدة سنوات وفي الوقت الحالي لديه حبن ← أول ما نفكر به هو **تشمع الكبد**.

## 3. السوابق الجراحية:

- حيث من الممكن أن يأتي مريض بألم في الحفرة الحرقفية اليمنى، والبديهي هنا أن نفكر بالتهاب الزائدة الدودية، ولكن عند سؤال المريض عن السوابق الجراحية أخبرنا بأنه استأصل الزائدة وعندها نفكر بداء كرون حيث أشيع مكان له هو الوصل اللفائفي الأعوري أو إذا كان المريض قادم من منطقة نائية فعندها يدخل السّل بالتشخيص التفريقي مع داء كرون لأن السل يفضّل كثيراً منطقة الدّقاق.

## 4. السوابق الدوائية:

- مثلاً:
  - مريض لديه قصة نزف هضمي علوي وبسؤالنا عن السوابق الدوائية قال إنه يتناول أسبرين منذ خمس سنوات وذلك بسبب ألم مفصلي ← لديه قرحة دوائية حتى يثبت العكس.

[2] هي أعراض التهاب معدة وأمعاء جرثومي.

[3] عندئذ يكون سبب الالتهاب هو الكحول وليس جرثومي.

- إذا أتى مريض بقصة إسهال مع العلم أنه يتناول صادات لسبب إنتاني ما ← من المحتمل أن يكون التهاب قولون غشائي كاذب.
- مريض بقصة قلع أسنان يعاني من إسهال ← غالباً يكون بسبب تناول دواء الأوغمنتين.

### 5. السوابق الطمثية (مهمة جداً):

يجب السؤال إذا كانت الدورة الشهرية: ❶ منتظمة أو لا. ❷ غزيرة أو لا. ❸ بالإضافة إلى مدتها.

### 6. السوابق العائلية:

نسأل عن وجود: ❶ أمراض قلبية وعائية. ❷ ضغط. ❸ سكر. ❹ سرطانات.

**وهذا السؤال هام:** وذلك لأن الأورام لها انتقالات وخصوصاً أورام الكولون أو أمراض الـIBD لها انتقال وراثي وكذلك داء ويلسون أو داء غوشر.

## الشكاية الرئيسية

- هي العرض الذي يدفع المريض لمراجعة الطبيب في قسم الإسعاف أو العيادة، وتكون عبارة عن عرض واحد، وإذا وجدت أعراض أخرى تعتبر مرافقة؛ مثلاً:
  - مريض لديه غثيان وألم بطني بشكل دائم ويراجع بقصة وجود دم في البراز، فالشكوى الرئيسية هنا هي **نزف هضمي سفلي** والباقي أعراض مرافقة.
  - مريض راجع الطبيب بعدة أعراض مع بعضها (ألم بطني وإسهال وإقياء) ففي هذه الحالة يمكن اعتبار أي عرض منها كشكوى رئيسية والباقي أعراض مرافقة.

في بعض الأحيان قد يخبرنا المريض عن العرض الأكثر إزعاجاً له وغالباً يكون **الألم**.

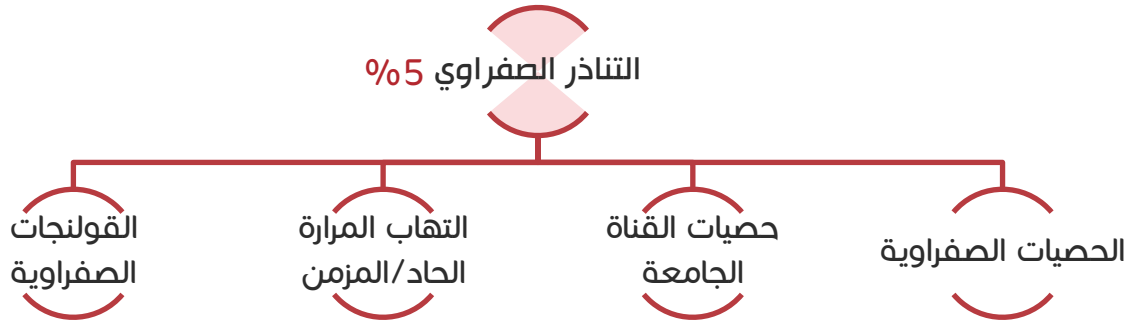
## القصة المرضية

- وهي تفصيل للشكاية الرئيسية.
- **أول** ما نسأله في تفصيل الشكاية متى بدأ الألم أو هذا العرض (الذي هو الشكاية الرئيسية)، وذلك لأن المريض الذي يعاني من ألم بطني من ثلاثة أشهر ليس كمريض يعاني من ألم بطني من ساعتين، حيث يختلف التشخيص تماماً.
- يجب **تفصيل الشكاية بشكل كافي** قبل الانتقال إلى الأعراض المرافقة:
- مثلاً لا نقول ألم بطني وننتقل للأعراض المرافقة، بل نقوم بتحديد **صفات الألم بشكل كامل**، فالألم البطني الكثير من الأسباب.
- لسهولة الوصول للتشخيص المناسب نقسم التشخيص إلى **تناذرات** نلغيها واحد تلو الآخر للوصول إلى التشخيص الصحيح.

- التناذر: عبارة مجموعة من الأمراض تشترك بعدة أعراض، فهو عبارة عن ربط مجموعة من الأمراض بمرض واحد؛ **مثال:** التناذر الصفراوي إما مرارة، أو التهاب طرق صفراوية، ... .

❖ يوجد **ثلاثة** تناذرات تشمل الألم البطني حيث 90٪ من أسباب الألم البطني تندرج تحت هذه التناذرات:







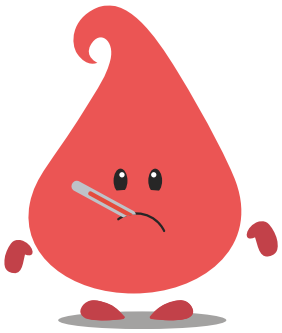


❖ أكثر عرض يأتي المريض الهضمي بسببه إلى الطبيب هو الألم، ويوجد سبع صفات للألم يجب معرفتها:

- **مكان الألم**
- **انتشار الألم**
  - ألم المرارة ينتشر للكتف
  - ألم القولنج القطني ينتشر إلى الظهر والمنطقة الخثلية
- **شدة الألم**
- **شكل الألم**
  - ألم ماغص: يدل على قولنج مراري - كلوي
  - ألم طاعن: التهابات البنكرياس - ألم أسفل المريء - احتشاء سفلي
  - ألم ممزق: تسلخ الأبهر
- **محرضات ومسكنات الألم**
  - في التهاب البنكرياس يخف الألم بالانحناء للأمام ويزيد بوضعية الاستلقاء
- **بدء الألم (نسأل عن كيفية بدء الألم)**
  - يبدأ بشكل مفاجئ
  - بشكل تدريجي
- **تردد الألم**
  - هل يهدأ أم يتصاعد مع مرور الوقت؟
  - الألم القولونجي المراري: يبدأ ألم يصل للذروة ثم يبدأ بالتراجع بعد ساعتين، أما التهاب البنكرياس مثلاً يبدأ ويزداد خلال 6 ساعات كثيراً

محرضات ومسكنات الألم: المريض الهضمي يقول لك أن ألمه زاد على الجهد، أما إذا قال لك أنه يرتاح بالانثناء للأمام فمعناه أن هناك سبب يخرّش البريتوان وقد ارتاح عندما انثنى للأمام لأنه في هذه الحالة ابتعد البريتوان عن العضو الذي فيه المشكلة، مثل التهاب البنكرياس والانثقاب القرحي.

مثلاً؛ أتى مريض سكري 60 عام بشكاية انتشار الألم الشرسوفي للظهر، لا نشخصه بقرحة مباشرةً، بل يجب أولاً أن نقوم بتخطيط قلب لأن احتشاءات السبيل الوعائي السفلي تتظاهر باقياءات وألم شرسوفي، وبما أنه مريض سكري فسيأتيك غالباً بعرض تعرّق بسبب اعتلال الأعصاب لديه.



## استعراض باقي الأجهزة

- ضروري وذلك لوجود تداخل بين أمراض مختلفة؛ مثلاً:
  - مريض لديه اضطراب في الوعي والتجاوب ممكن أن يكون بسبب **اعتلال دماغي كبدي**.
  - القولنج الكلوي يمكن أن يسبب ألم بطني.
  - عسر البلع يمكن أن يكون بسبب **سلعة درقية (ضخامة درقية)**.
  - مريض تعرّض **لحادث وعائي دماغي** فتأثرت لديه المعصرة المريئية العلوية لذلك يحدث لديه عسر بلع خصوصاً بالفترة الحادة من الإصابة (أول 6 أسابيع).

## الفحص السريري

- شروط الفحص السريري:
  - أن يكون الطبيب على يمين المريض[4].
  - غرفة دافئة مضاءة بشكل جيد.
  - طاولة الفحص مرتفعة بشكل مناسب للطبيب.
  - عطف فخذيّ المريض نحو البطن للتقليل من توتّر وتشنّج عضلاته ليسهل الجسّ وللحصول على نتيجة مجدية.
  - يجب أن تكون يد الطبيب دافئة لأن اليد الباردة تغيّر من وتيرة الأصوات الحوية وتسبب تشنج عضلات البطن.

الفحص السريري لايتمّ لكل جهاز تلوَ الآخر بل **لجميع أجهزة الجسم معاً** من الرأس حتى أخمص القدمين.

- الفحص السريري يشمل:
  - فحص العلامات الحيوية:

| ضغط | نبض | حرارة | معدل تنفس |
|---|---|---|---|

[4] طريقة أكاديمية يجب عدم التقليل من أهميتها (انتبه بنقصوا عليها علامات بالفحص).

## أولاً: الانطباع العام

- هل المريض **واعٍ** أم لا؟ هل المريض **متجاوبٌ** أم لا؟
- **الوزن:** هل المريض مدنف (نقص وزن شديد) وهنا نفكّر بأمراض مزمنة، سرطانات ...
- **الجلد:** حيث أنّ العديد من الأمراض الهضميّة تتظاهر جلديّاً، مثلاً تدلنا ملاحظة الشواك الأسود على **أن المريض لديه مقاومة للأنسولين بغض النظر عن سببها أو بدين بدانة مفرطة أو لديه أورام معدة.**

## ثانياً: الرأس

- ونفحص في الرأس ما يلي:

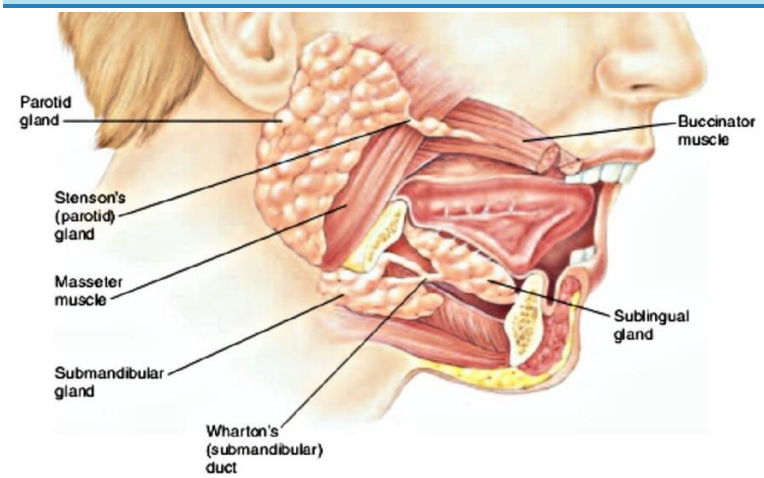
العين | الغدة النكفية | الفم | الرقبة

### 1. العين:



- الملتحمة **شاحبة** بشدة ← **فقر دم.**
- الصلبة والملتحمة **صفراء** ← **يرقان** بأنواعه.
- ونميزه عن فرط كاروتين الدم بأن الصلبة في فرط الكاروتين لا يتحول لونها للأصفر.
- فحص تعريض حدقة العين للضوء وتفاعلها معه في الجانبين فإذا كانت النتيجة **سلبية** ← **الخلل يكمن في جذع الدماغ.**

### 2. الغدة النكفيّة:




- حيث أن هناك حالات نادرة من **التهاب البنكرياس** يكون سببها **النكاف.**
- مريض التهاب الكبد الكحولي أو تشمع الكبد الكحولي سنجد لديه التهاب **غدة نكفية ثنائية الجانب**، أما بالنكاف فتكون **أحادية الجانب ومؤلمة.**

### كيف نفحص الغدة النكفية؟

- الغدة متوضعة بين العضلة الماضغة والأذن **وفي الحالة الطبيعية لا تُجسّ**، ولفحصها نطلب من المريض **كزّ الأسنان** فإذا جسّت فهذا دليل **ضخامتها.**

## 3. الفم:

- فحص اللسان:

إذا كان جافاً كالخشبة ← **تجفاف** وقد يكون بسبب الإسهال أو الصيام. (الصورة جانباً)

إذا كان جافاً بدون تجفاف والمريض يتنفس من فمه ← **مشكلة أنفية** (ضخامة قرينات).

إذا وُجد لون يرقاني تحت اللسان أثناء فحصه فهو إشارة **لآفات الكبد** (اليرقان) أو **آفات انحلال الدم**.





التهاب اللسان الفطري

ناتج عن تناول أدوية ستيروئيدية والتثبيط المناعي



ضمور حليمات اللسان

بسبب عوز الحديد وفيتامين B12 وB9



لسان أحمر مؤلم لامع ملس

يشير لعوز الحديد والB12

- وجود القلاع في الفم ← (**داء كرون** - **داء بهجت** - **التهاب الكولون التقرّحي** - **مشاكل سنية** - **داء زلاقي غير مضبوط** - **عوز بعض الفيتامينات** - **بعض الأدوية**).



ودائماً في حال وجود قلاعات بالفم لدى المريض نسأله عن وجود قلاعات تناسلية.

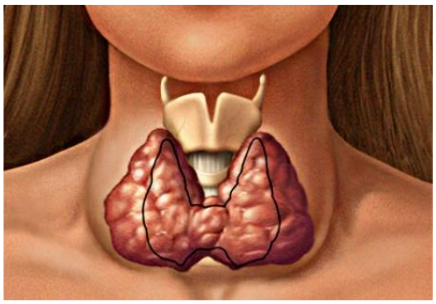
قد نلجأ في بعض الأحيان إلى استئصال القلاع إذا كانت الشكوى مستمرة لأكثر من سنة وتأتي كل 15 يوم مع ألم دون القدرة على تناول الطعام والبلع، ففي هذه الحالة يجب أن نوسع الدراسة لمعرفة الأسباب.

- تضخم اللوزات يؤدي إلى عسرة بلع.
- اللسان الجغرافي: حيث تظهر تبدلات حلقية ودائرية على سطح اللسان ممكن أن تكون بلون **أحمر** كما يمكن أن تغيب الحليمات ويكون غير مؤلم عادة (ممكن أن يحدث بسبب عوز فيتامين B2).
- تشقق زوايا الفم يشير إلى عوز الحديد.

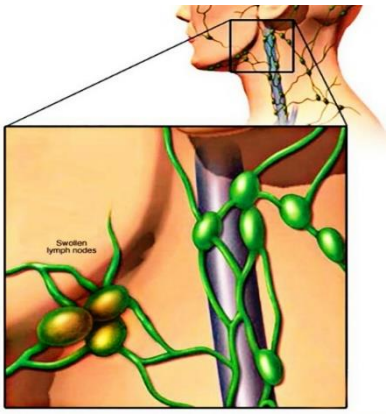


صورة توضّح بعض درجات تضخّم اللوزات

## 4. الرقبة:



- **ضخامة الغدة الدرقيّة.**
- **ضخامة العقد اللمفاويّة** (تحت الذقن والوداجيّة وأمام الترقوة) وهي في الحالة الطبيعية لا تجسّ إلا عندما تتضخم في بعض سرطانات جهاز الهضم كسرطان المريء، **وتوصف ضخامة العقد اللمفاوية من حيث:**
  1. **القوام:** في هودجكن تكون العقد مطاطية.
  2. **الحجم.**
  3. **الألم:** حيث تكون الأخماج فيها مؤلمة.
  4. **الحركة:** المتثبّتة دائماً تشير لأورام وخباثات.
- **نبض السباتيين.**
- **انتباج الوداجيين:** في **قصور القلب الأيمن.**
- **صلابة النقرة:** في حال كان لديه ترفع حروري كما في **التهاب السحايا.**




**كيف نميّز بين ضخامة العقد اللمفاويّة وضخامة الغدة الدرقيّة؟** RBO Clinical

- في فحص العنق؛ **الغدة الدرقية تتحرّك مع البلع** بينما العقد اللمفيّة لا تتحرّك، لذلك إذا بقيت ثابتة فليست غدة درقيّة وإذا تحرّكت فهي غدة درقيّة.

## ثالثاً: الطرفين العلويين

- **النبض المحيطي**؛ هل هو مجسوس أو لا.
- جسّ **العقد اللمفاويّة** تحت الإبط.
- نرى هل هناك قلة أشعار أو لا، لأن قلة الأشعار تدلنا على أن تشمع الكبد بالمراحل **المتقدمة.**
- **الرّعاش الخافق:** أي شيء يحبس الـ$CO_2$ سيسبب رعاش خافق ← فرط نشاط الدرق - قصور الخلية الكبدية - الكحولية - تشمّع الكبد - اعتلال دماغي كبدي.
- **الأظافر البيضاء** ← تعكس نقص الألبومين - اعتلال الأمعاء - ضياع البروتين - النفروز - قصور خلية كبدية.
- **راحة حمراء** ← قصور الخلية الكبدية - تشمع الكبد - وبالحالات الفيزيولوجية يمكن أن تشاهد في الحمل.



الراحة الحمراء
(حمامى راحية)

الأظافر البيضاء



# رابعاً: الصدر

## التأمّل:

نتحرى شكل الصدر وطبيعة التنفس.

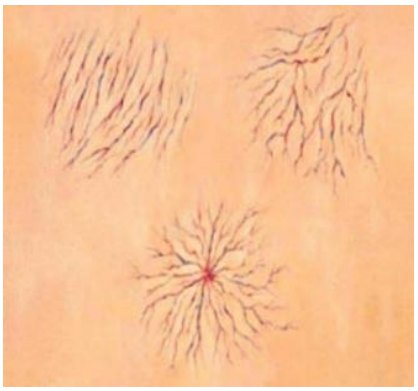
نتحرّى وجود الزلّة التنفسية حيث أن أهم علامة لها هي:

- ✓ سحب فوق القص.
- ✓ سحب بين الأضلاع.

**السحب**

هو تحرك المنطقة مع التنفس بشكل ظاهر وجليّ

عند الشخص الطبيعي؛ يتمدّد الجلد ويعود لوضعه الطبيعي عند أخذ الشهيق والزفير، أما في حالة الزلّة التنفسيّة سيمتد السحب للعظم وهذا يشير إلى مشكلة بالتنفس (ربو، COPD، ..).



وجود عناكب وعائيّة؛ تكون موجودة على كامل توزع الأجوف العلوي (بما فيه الرقبة والطرفين العلويين):

- ✓ عند **النساء**، يتراوح عددها من 4-5 عناكب وعائية ولاسيما عند **الحوامل**.
- ✓ عند **الذكور**، وجودها يشير إلى عدة أمراض كتشمع الكبد، ... (أي شيء يسببه **فرط الاستروجين**).

وجود الدوران الجانبي: سببه **انسداد** الوريد الأجوف العلوي.

## الإصغاء:

نصغي القلب والصدر.

# خامساً: البطن

## التأمّل:

ويهمّنا **فيه ثلاثة** أمور:

### 1. حجم البطن:

- في الشخص **البدين** من **الطبيعي** أن يكون **بطنه كبيراً** و**السرّة منطمرة** في الشحوم.
- إذا كان الشخص **نحيل** ولديه **ضخامة بطنيّة** فهذا أمر **غير طبيعي**، كما يجب علينا أن نتحرّى إذا كانت الضخامة متجانسة أو لا؟

## ضخامة متجانسة

- ☑ يكون البطن ممتلئاً **بالماء** أو **الهواء**.
- ☑ **الماء أو السائل الحر (الحبن):** تكون ثنيات السرّة **غائبة** والسرّة نجدها تتجه للأسفل، وهذا مايميزه عن الحمل -عند الأنثى- حيث تختفي أيضاً الثنيات بالنسبة للسرّة لكن اتجاهها للأعلى.
- ☑ **الهواء:** ناتج عن انسداد الأمعاء أو خزل (كسل) الأمعاء وثنيات السرّة **لاتزول (موجودة)**.

- في حالتي الحمل والحبن: تكون ثنيات السرة **غائبة**.

## ضخامة غير متجانسة

- ☑ يكون هناك ضخامة أو ورم في أحد **الأحشاء** كضخامة الكبد أو الطحال.



حبن
(اتجاه السرّة للأسفل)



حمل
(اتجاه السرّة للأعلى)

التضخّم في المنطقة الخثليّة يمكن أن يكون سببه الكرة المثانيّة، وذلك بعد العمليّات الجراحيّة أو بعد التخدير القطني (خزل مثانة) ويرافقه ألم.

### 2. حركات البطن:

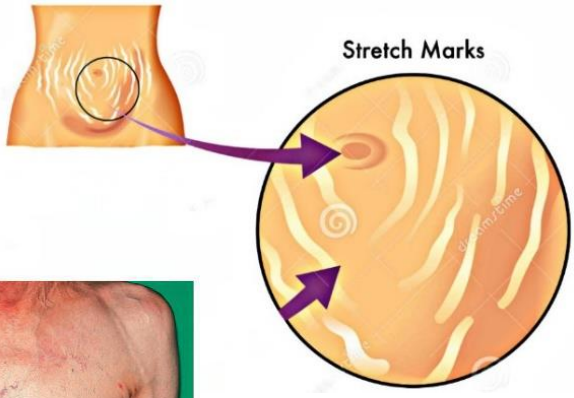
- **يتحرّك** مع التنفس ← **طبيعي**.
- **لا يتحرّك** مع التنفس ← السبب **تخريش البريتوان** نتيجة عمل جراحي أو خرّاج أو إنتانات داخل البطن.
- **حركات نبضية** في الشرسوف أو بين الشرسوف والسرة ← **أم دم أبهر بطني**.
- في حال وجود أم دم؛ **يُمنع الجس لأنه قد يحدث تمزق**.
- إذا كانت الحركات الحوية للأمعاء **ظاهرة** بشكل عياني على بطن المريض وكان نحيفاً ← لديه **انسداد أمعاء** يوافقه زيادة في تلك الحركات.
- إذا رأيت المريض يحاول حبس نفسه قدر الإمكان لكيلا يحرك جدار البطن نسمي هذه الحالة بطن غير متنفّس، وهذا يدل على **تخريش بريتوان (انثقاب قرحي أو التهاب بنكرياس)**.
- يتحرض الألم في **التهاب البنكرياس** عند الاستلقاء (بسبب تحريك البريتوان).

## كشف وجود الفتق الإربي سريرياً: RBO Clinical

- ويُتعبر إجراء هام عند فحص البطن، حيث نطلب من المريض[5] أن يسعل ونضع اليد عند مكان الفتق الإربي الأيمن أو الأيسر، إذا حصل اندفاع تحت اليد عند سعال المريض فهذا يدل على وجود فتق، لذلك نطلب من المريض السعال بحالتين:

⬅ الطبيب واقف يتأمل فقط. ⬅ الطبيب يضع يده على مكان الفتق.

## 3. جلد البطن:





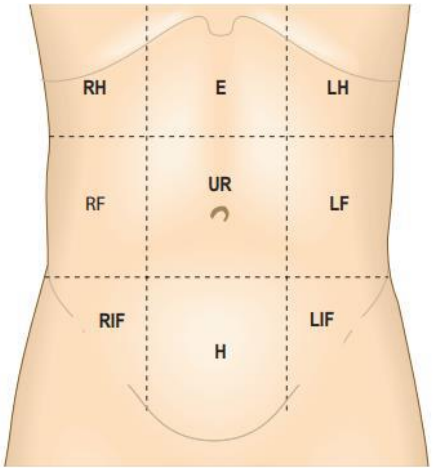

دوران وريدي جانبي

- نرى آثار و**ندبات** العمليات الجراحية السابقة.
- **لون** يرقاني.
- دوران وريدي جانبي.
- عناكب وعائيّة.
- من الممكن أن نرى مايدعى بالفزر الحمليّة عند النساء في فترة الحمل وعند زيادة وزنهن في تلك الفترة.
- دوران حول السرة (رأس الميدوسا) يترافق مع فرط توتر وريد الباب ومشاكل تشمّع الكبد.

## الجس:

- الأيدي الباردة عند الجسّ **تسبب تشنُّج عضلات البطن** لدى المريض وتزعجه فلذلك يجب تدفئة اليدين قبل الجسّ.
- عند الجسّ راحة اليد تكون بكاملها على جدار البطن والجسّ برؤوس الأصابع.
- للجسّ نوعان سطحي وعميق:

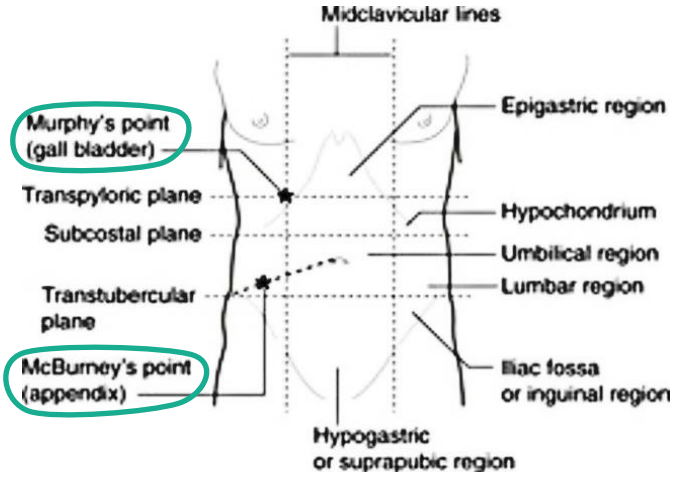
## 1. الجسّ السطحي:




- يبدأ من الحفرة الحرقفيّة **اليسرى** ونتجه بعكس عقارب الساعة حتى نشمل نواحي البطن الـ9.

يكون ترتيب النواحي عند الجس: الحفرة الحرقفية اليسرى LIF - الخاصرة اليسرى LF - المراق الأيسر LH - الشرسوف E - المراق الأيمن RH - الخاصرة اليمنى RF - الحفرة الحرقفية اليمنى RIF - المنطقة الخثلية H - المنطقة السرية UR. (وفق الصورة المجاورة)

[5] للأعمار الكبيرة والأعمار الصغيرة (كالأطفال).




- يفيد في معرفة **مقويّة جدار البطن**.
- نبحث عن الفتوق.
- نبحث عن نقاط ألميّة؛ مثل:

**ماك بورني**: نقطة التقاء الثلثين الإنسيين بالثلث الوحشي (بين الشوك الحرقفي الأمامي العلوي الأيمن والسرة)، إذا كانت هذه النقطة مؤلمة عند جسّها ← **ماكبورني إيجابية**، تدلّ غالباً على التهاب الزائدة الدودية.

**مورفي**: تقع أسفل منتصف الحافة الضلعية اليمنى، على امتداد الخط منتصف الترقوة (قريبة من مكان الحويصل الصفراوي)، ولفحصها؛ نطلب من المريض أخذ نفس عميق ونضع يدنا على المكان تحت الحافة الضلعية اليمنى فإذا تحرض ألم في المنطقة أثناء التنفس ← **مورفي إيجابية**، تدل غالباً على أن المريض لديه التهاب في جدار المرارة.

- الجس السطحي يفيد بالتحري عن وجود **كتل دهنية** على جدار البطن الخارجي.
- يجب الأخذ بالاعتبار أن **البدء** بالجسّ يكون بعيداً عن منطقة الألم، حتى لا يحرض الجس ألم شديد ويهيّج عضلات البطن، بحيث نسأل المريض قبل الجس عن وجود الألم وموقعه وذلك لكي نبدأ من منطقة بعيدة عن الألم باتجاه منطقة الألم.

**وجود ألم**: لا يكون الجس بالطريقة التقليدية، حيث نبدأ بالجس بعيداً عن الألم باتجاه منطقة الألم

**عدم وجود ألم**: الجس يكون بالطريقة التقليدية، حيث نبدأ من الحفرة الحرقفية اليسرى ونتجه بعكس عقارب الساعة، مثال: جس الطحال يبدأ من الحفرة الحرقفية اليمنى باتجاه المراق الأيسر (بشكل مائل)

## RBO Clinical — كيف نميز الكتلة في البطن أهي على حساب جدار البطن أم الأحشاء؟




- من خلال **علامة كارنيت** Carnett's sign: حيث نعمل على توتير جدار البطن وزيادة الضغط فيه، وذلك بأن نطلب من المريض **رفع رأسه**، ونقاوم ذلك بوضع اليد اليسرى على جبهته، ونطلب أيضاً **رفع ساقية** (بدون ثني الركبة)، وبالتالي:

✓ إذا كانت الكتلة على **جدار البطن** ← تبقى محسوسة.

✓ إذا كانت الكتلة **داخل تجويف البطن (على الأحشاء)** ← تختفي.


محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

## 2. الجسّ العميق:

- يفضّل أن يكون الجس **بكلتا اليدين**، حيث نضع اليد اليمنى بكاملها على البطن ونضغط عليها باليسرى لزيادة قوّة الجسّ وعمقه.
- في الحالة **الطبيعية** لا يمكن جس أي عضو من أعضاء البطن.
- عند وجود كتلة ما يجب تحديد مكانها بدقة، وهل هي مؤلمة أو لا، ومتحرّكة أو لا.

## فحص الطحال

☑ جس الطحال يبدأ من الحفرة الحرقفية اليمنى على الرغم من وجود الطحال في الأيسر (وذلك لأن الطحال عندما يتضخم **بشكل قاطع للسرة**، وإذا كانت الضخامة شديدة ممكن أن تصل للحفرة الحرقفية اليمنى).

☑ يُجس برؤوس الأصابع ومع كل ضغطة نطلب من المريض أن يأخذ نفس حتى يتحرك الطحال للأسفل.

☑ وعندما نجس الحافة السفلية للطحال نحدد بُعدها عن الحافة السفلية للأضلاع، وأيضاً نحدد فيما إذا كانت ملساء أم متعرجة، كما نتحرى وجود ألم أثناء الجس.

القطب العلوي للطحال لا يمكن جسه لأنه موجود في المسافة الوربية التاسعة.

## فحص الكلية

☑ نضع يدنا اليمنى على الخاصرة وندخل اليد اليسرى خلف المنطقة القطنيّة ونحاول أن نلاقي اليدين معاً من خلال البطن، فإذا جسسنا الكلية تكون متضخمة.

☑ الكلية في الحالة الطبيعية لا تُجسّ إلا برؤوس الأصابع (في حالات نادرة عند الأشخاص **النحيلين**)، ولانجسّ فيها إلا **القطب العلوي**.

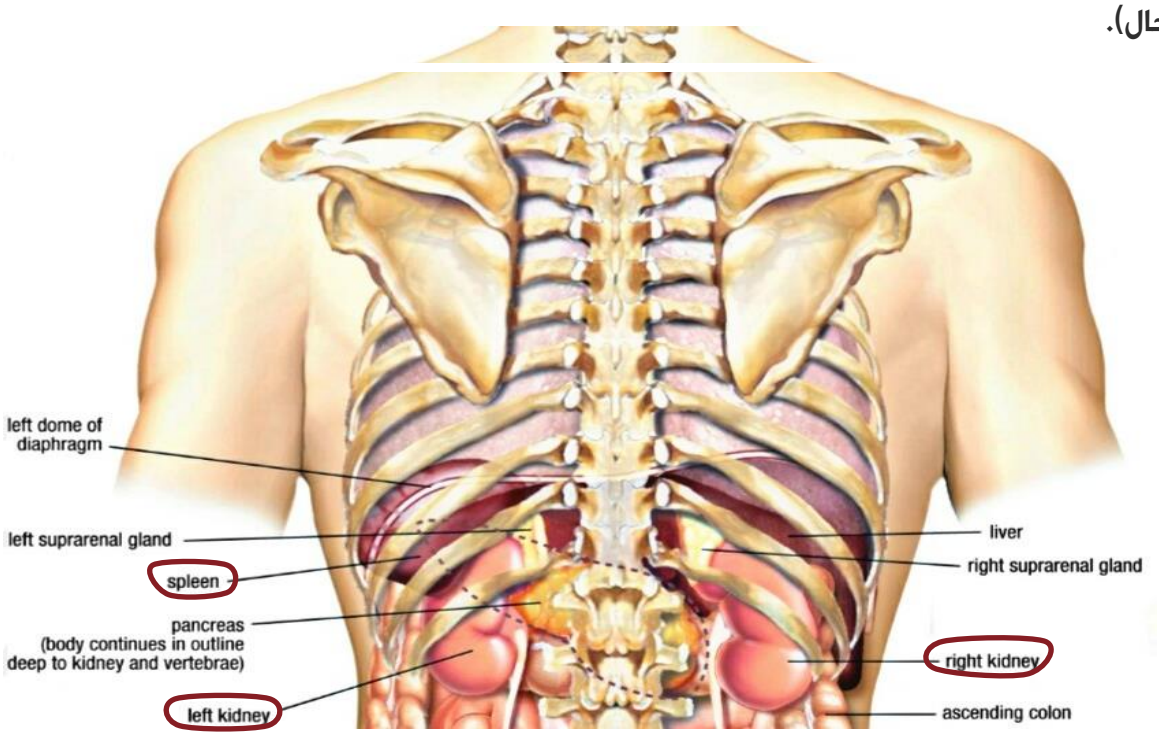
- في الكلية نجس القطب العلوي فقط وفي الطحال نجس القطب السفلي فقط.

### كيف نميّز ضخامة الطحال عن ضخامة الكلية؟ RBO Clinical

- التنفّس هو الحل حيث أنّ الطحال **يتحرّك مع التنفّس** بسبب الحجاب الحاجز بينما الكلية **لاتتحرّك مع التنفّس**.
- يمتد الطحال من الورب 9 حتى الورب 11، فالقرع عند الطحال وتلك الأوراب يكون أصمّياً، أما إذا كان طبلياً فنحن أمام حالة **نفاخ رئوي** دفعت الطحال للأسفل - مصاب بالـCOPD، فبدل أن يكون القرع أصمّياً في الورب التاسع أصبح أصمّياً في الورب العاشر، وكذلك الكبد فبدل أن يكون أصمّياً في الورب الخامس[6] أصبح أصمّياً في الورب السابع.

[6] أي مستوى حلمة الثدي.

- أما القرع في الكلية فيكون **طبلياً** لأنها واقعة خلف البريتوان والأحشاء أمامها.
- القرع هو الوسيلة لتمييز ما إذا كانت حالة COPD (هبوط بالحجاب الحاجز) أم هناك ضخامة في العضو (مثل الكبد والطحال).




## فحص الكبد

☑ الكبد في الحالة الطبيعية يمتد من **الورب الخامس** على خط منتصف الترقوة وحتى **الحافة السفلية للأضلاع اليمنى**.

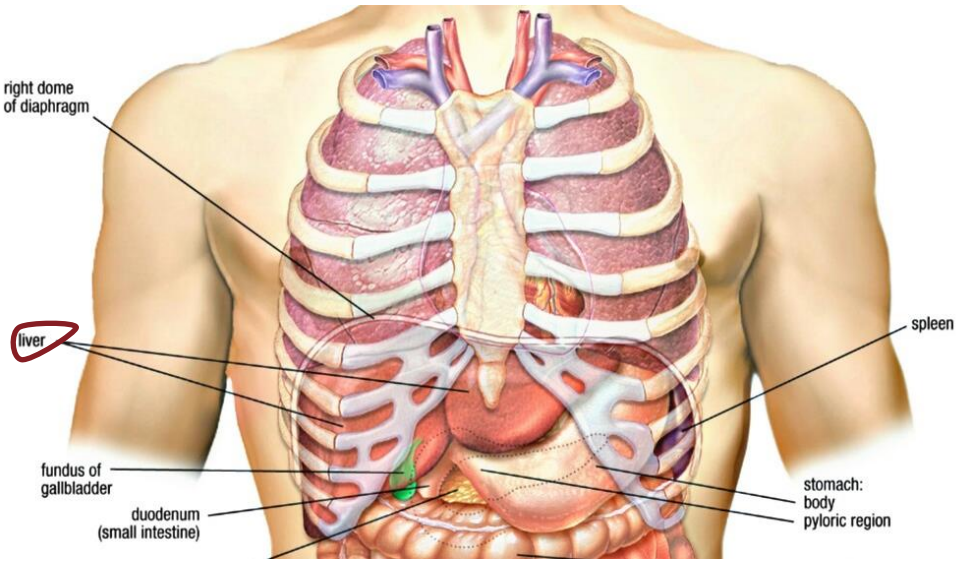
☑ **غير مجسوس** طبيعياً، ولكن يمكن جس الحافة السفلية منه عند **النحيلين** جداً.

☑ نقوم بتوصيف ضخامة الكبد كما يلي:

✓ **مقدار الضخامة:** نحددها بعدد الأصابع تحت الحافة الضلعية.

✓ **الألم:** تكون الضخامة مؤلمة بشدة في قصور القلب الأيمن والتهاب الكبد.

✓ **متعرجة أو ملساء**.



## ملاحظات سريرية:

- هناك أشخاص لديهم إصابة عصبية بالحجاب الحاجز أدت إلى شلّه، ففي تلك الحالة نجد عند الجس أن القسم الأكبر من الكبد **يُجس أسفل الحافة الضلعية**.
- بالجس نقدّر بعدد الأصابع؛ أي نقول: الكبد مجسوس أربع أو خمس أصابع تحت الحافة الضلعية اليمنى.
- الضخامات أكثرها تحدث عند التهاب الكبد الفيروسي الحاد والتشمع الكبدي (بداية التشمع بسبب وجود عقيدات تجددية) لذلك عند الجس من الضروري أن نحدد ما إذا كانت الضخامة متجانسة أو لا:

⇐ في التهابات الكبد الفيروسية الحادة يكون قوام الكبد **متجانساً**.

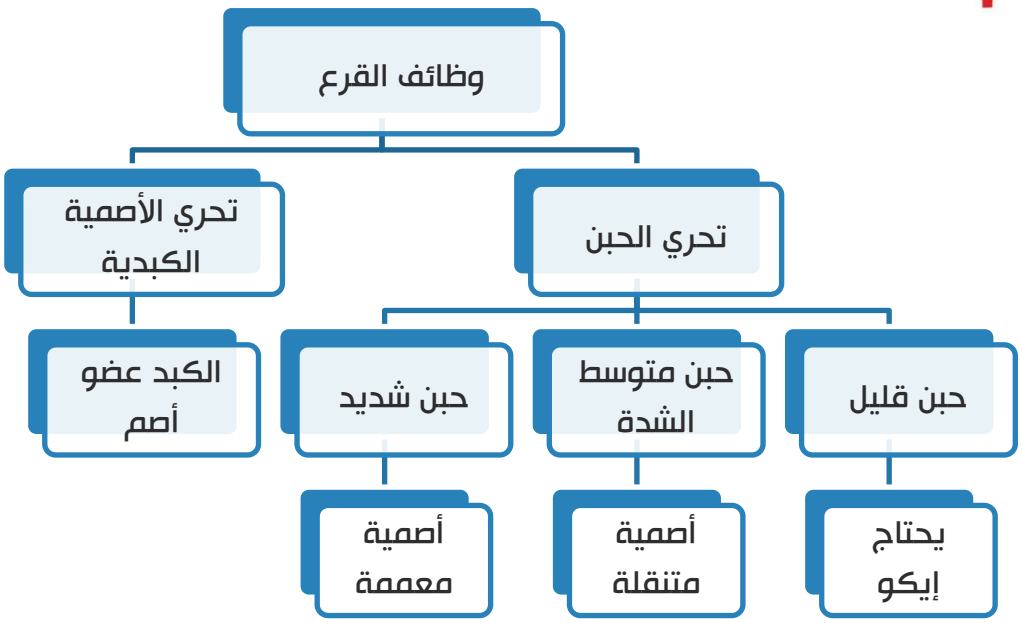
⇐ في العقيدات التجددية سنجد أن الكبد **غير متجانس أبداً** (متجمع بشكل عقيدات) وكذلك الارتشاحات الورمية على الكبد.

## القرع:

- يتم القرع بحيث تكون اليد **اليسرى ملامسة تماماً** لجدار لبطن و**نقرع باليمنى**.
- **طبلية رنّانة** ← البطن **طبيعي**.
- **أصمّية موضّعة** ← **ضخامات أو كتل**.
- **أصمّية مقتصرة على الخاصرتين أو السرّة:** نقوم بقلب المريض على جانبه **الأيسر** وبعدها نقرع على الخاصرة **اليمنى** و**السرّة** فنجد أن السرّة أصبحت **أصمّية** بينما الخاصرة **اليمنى** أصبحت **طبلية** فهذه حالة **حبن متوسّط الشدّة**.
  - لكشف الحبن متوسط الشدة (1-2.5 ليتر من السائل) نجري عملية الأصمية المتنقلة -إذا كانت الأصمية مقتصرة على الخاصرتين- حيث أنه إذا كانت كتلة مائية فستتحرك أي سيعود الصوت أما إذا بقيت أصمية فيكون هناك كتلة في هذا المكان (**الكتلة تبقى ثابتة أما الماء فيتحرك**).
- **فرط طبليّة:** غاز حرّ بجدار البطن ناجم عن **انسداد** أمعاء **فتتوسّع أغلبها**.
  - انثقاب حشا أجوف (أي مشكلة تسبب انثقاب **أمام** البريتوان)، أما انثقاب **خلف** البريتوان يسبب مشكلة خلف (حول) الكليتين.
  - في الانثقاب أمام البريتوان نلاحظ بالتصوير **تجمع الغاز أمام الحجاب الحاجز** ← انثقاب حشا أجوف.
  - نجد طبلية بدلاً من الأصمية **لوجود غاز فوق الحافة العلوية للكبد** (عند الحافة السفلية للحجاب الحاجز).

- علامة مرضية: بالقرع عند الورب 10 أو 11 عند مريض بالجهة اليمنى شعرنا بطبلية ← غابت أصمّية الكبد فغياب الأصمّية الكبدية يشير إلى انثقاب حشا أجوف (غاز حر).






## التمييز بين ضخامة الكبد وهبوط الكبد سريرياً: RBO Clinical

- عند البدء بالقرع لاحظنا وجود أصمية للكبد عند الورب الخامس ومستمرة تحت الحافة الضلعية ← **ضخامة كبد**.
- عند البدء بالقرع لاحظنا وجود أصمية للكبد عند الورب السابع على سبيل المثال ومستمرة تحت الحافة الضلعية ← **هبوط كبد**.

## الإصغاء:

تختلف المراجع عما إذا كان الإصغاء قبل الجس أم بالعكس، لكن عملياً **الإصغاء قبل الجس** لأن الجس يمكن أن يغير من وتيرة الحركات الحوية.

يجب ألا يقل الإصغاء عن 90 ثانية (دقيقة ونصف) وألا يزيد عن 3 دقائق.

نصغي **أسفل وأيمن السرّة** بعد ضغط السمّاعة بشكل **خفيف**.

✓ حيث نفضل هذه المنطقة (أسفل وأيمن السرة) لأنها منطقة الوصل اللفائفي الأعوري -منطقة ترانزيت (عبور)- من الأمعاء الدقيقة إلى الكولون، فهذه المنطقة مهمة لسماع الحركات الحوية.

**الأصوات الحويّة** للأمعاء هي أصوات **قرقريّة** بمعدل طبيعي قدره (5-25) حركة \ دقيقة.

✓ **أقل من 5 حركات:** ضعيفة جداً ويصاب بإمساك ← **خزل (كسل) معوي**.

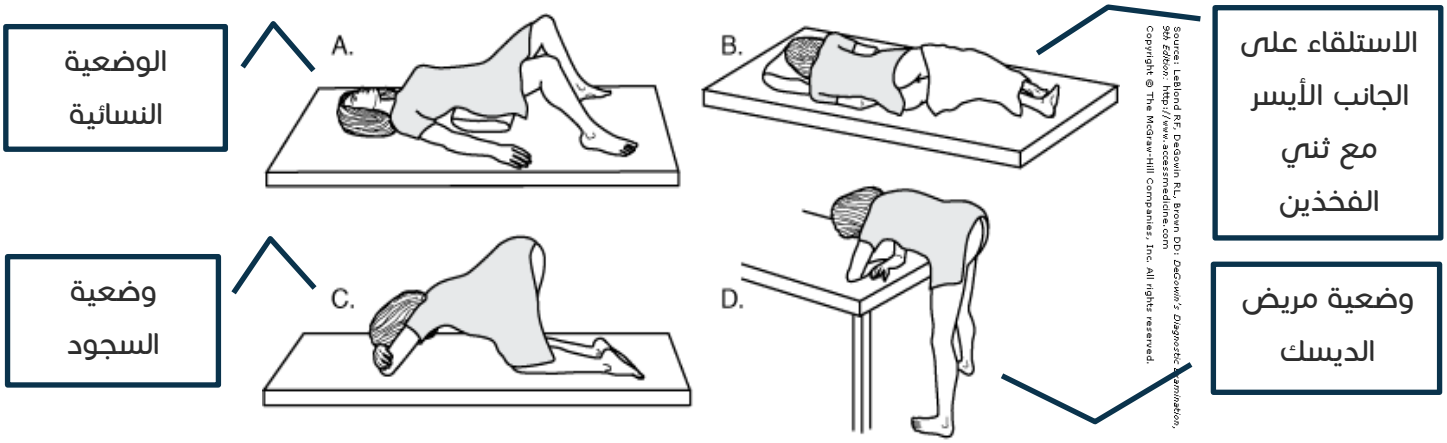
✓ **أكثر من 25 حركة:** فرط حركات معويّة ← **إسهال** أو **مراحل بدائية للخزل** لأن الأمعاء تحاول أن تتقلص وتقاوم الانسداد ثم تقف.

**علامات تخريش البريتوان**

1. البطن الخشبي القاسي ويسمى بالبطن الجراحي.
2. بطن غير متنفّس: المريض يتنفّس بشكل سطحي خوفًا من الألم.
3. أصمّية كبدية غائبة لوجود غاز حر.
4. غياب الحركات الحوّية.

## سادساً: الشرج

| استطباباته | وضعيات فحص الشرج |
|---|---|
| نزف هضمي سفلي | وضعية الاستلقاء على الظهر مع ثني الفخذين (الوضعية النسائية) |
| إمساك مزمن | وضعية الاستلقاء على الجانب الأيسر مع ثني الفخذين |
| انسداد أمعاء | وضعية السجود |




- وضعية السجود أكثر وضعية مستخدمة.
- في حال كان لدى المريض ديسك، نضع له طاولة أخفض من مستوى جسمه يثني عليها جسمه (تقريباً تشبه وضعية السجود).

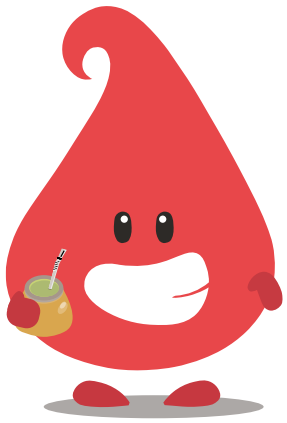
### يشمل الفحص الشرجي ما يلي:

1. نفحص المريض **عيانياً** للتأكد من وجود **شقوق شرجيّة** أو **بواسير خارجيّة** وخاصة عند الساعة 6 و12 في الوضعيّة النسائيّة.

في حال وجود شقوق شرجية عند الساعة 3-9 أو الساعة 10 فهذا يعبر عن الـIBD (داء معوي التهابي) ممكن أن يكون مترافق مع **داء بهجت** أو **سل** ← (**عدم** وجود شقوق على الخط الناصف أي 6 أو 12 يدل على مشكلة).

الشقوق في المناطق على **الخط الناصف** (6 و12) هي شقوق وصفية ← **طبيعية**.

2. نطلب من المريض الضغط (كما لو أنّه يقضي حاجته) للتأكد من وجود:



- **بواسير داخلية:**
  - فتخرج ثم تدخل بعد الانتهاء من الكبس.
  - حليمات باسورية داخلية درجة ثانية أو ثالثة.
  - الدرجة الأولى تخرج للخارج ثم تدخل **بعد انتهاء الكبس (الضغط)**.
  - الدرجة الثانية تخرج للخارج وترتد **بشكل عفوي**.
  - الدرجة الثالثة تخرج للخارج ولا ترتد إلا **بشكل يدوي**.
  - الدرجة الرابعة **نجدها عيانياً دون الطلب من المريض أن يضغط**.
- **بوليبات:** عبارة عن قطع لحم كالثآليل ناتجة عن فرط النمو، ذات شكل معيَّن أو لاطئ، وتسمى بالأورام الشبابية.
  - تخرج ثم تدخل ومن الممكن ألا تدخل.
  - يشيع وجود البوليبات في **المستقيم عند الأطفال**.
- **هبوط المستقيم:**
  - من الممكن أن يكون هناك هبوط مستقيم فتخرج المخاطيّة أثناء الكبس (الضغط)، ويشكي المريض من **زحير** أثناء الخروج (يخرج مادة مخاطية ويشعر كما لو أنه لم يفرغ البراز).
  - فحص هبوط المستقيم مهم لأنه يعبر عن وجود **كتلة داخلية** خصوصاً عند كبار السن.



بواسير خارجية وداخلية



حالة هبوط المستقيم

3. نضع مادة مزلقة على السبّابة، حيث نستخدم المادة المزلقة (**كاللِيدوكائين**) خاصةً في حال وجود الشق الشرجي لكيلا نحرض الألم لدى المريض، ونضعها في باطن الشرج وننتظر حتى ترتخي المصرّة، ومن ثمّ نزلق الإصبع إلى الداخل ونطلب من المريض أن يضغط ثانيةً (والإصبع في الداخل) لنفحص المقويّة الشرجية، فنكون أمام الحالات التالية:

- **ضغط** الشرج على الإصبع؛ **المقوية سليمة**.
- المقوية **ضعيفة**؛ سلس برازي.
- المقوية **فاقدة لقوتها**؛ فنحن أمام عدة حالات:
  - في بعض حالات الولادة يحدث توسيع مفرط للفرج (فتضعف عضلات المُعصّرة الشرجية)
  - حدوث خطأ ما في عمليات البواسير والشق الشرجي أدى لنفس الحالة السابقة
  - المريض هو طفل تعرّض لحالة اغتصاب

4. ندخل إصبعنا أكثر إلى المستقيم ثم نطلب من المريض أن يضغط مرة أخرى بحيث ينزل المستقيم قليلاً وذلك لنتحرّى الأورام أو الكتل القاسية.
5. ندوّر الإصبع 360 درجة في المستقيم لكي:
   a) نبحث عن الارتشاحات الورميّة في المستقيم.
   b) نبحث عن **البروستات** على الوجه الأمامي (عند الذكور).
   c) نبحث عن رتج **دوغلاس** على الوجه الأمامي (عند الاناث) فإذا كان هنالك ألم فيه فهذا يدلّ على تخريش بريتواني.
6. عند إخراج الإصبع نلاحظ ونرى لون البراز:
   a) براز **زفتي** ← مشاكل الأعور (مشاكل بعيدة عن منطقة الشرج) ← نزف هضمي علوي.
   b) براز **مُدمى** ← نزف هضمي سفلي "مستوى المستقيم والكولون السيني والنازل" ← (رتوج - بواسير - شق شرجي - بوليب متقرّح).
   c) براز **مارون** (أحمر قرمزي) يدل على نزف رتوج ← (مشاكل قريبة من منطقة الشرج).

## سابعاً: الطرفين السفليين

❖ توذم واحمرار في الساق وخاصة في الربلة مع وجود زلّة تنفسية وانخفاض للضغط (صمّة رئوية)، نستنج أنه يوجد **التهاب وريد خثري عميق**.

- DVT ← (احمرار في قدم واحدة مع ارتفاع حرارتها) أو هبوط ضغط وقصور تنفس مع هذه العلامات ← نشك بالصمة الرئوية.
- أو ممكن أن توجد حمامى عقدة على السطوح الباسطة والأطراف تكون مؤلمة ← التهاب قولون تقرحي، سل، ... (لها أسباب كثيرة).
- تقيح جلد مواتي ← نراه كثيراً مع داء كرون.

❖ الحركة.
❖ النبض المحيطي.
❖ تحري المنعكسات الوترية والجلدية.
❖ فحص العقد اللمفاوية المغبنية.

- المنعكسات الوترية ثنائية أو ثلاثية الرؤوس، الداغصة، الكاحلي.

## الفحوص المتممة

| | | |
|---|---|---|
| تنظير هضمي علوي للمريء والمعدة | تنظير أمعاء دقيقة كامل | تنظير كولونات |
| تحري الدم الخفي بالبراز | ERCP | MRCP |
| MRI | CT | ECHO |
| فحوصات دم كاملة مع وظائف كبد | الصورة الشعاعية البسيطة والظليلة | |

| | |
|---|---|
| ERCP | • Endoscopic retrograde cholangiopancreatography. |
| MRCP | • Magnetic resonance cholangiopancreatography. |
| MRI | • Magnetic resonance imaging. |
| CT | • Computed tomography. |

## حالات سريرية

**حالة 1:** مريضة بعمر الـ14 سنة يظهر عليها لون يرقاني، وبالفحص السريري تبين أنها كانت مصابة بكريب شديد وفقدت شهيتها للطعام ثم بدأت بالإقياء ولديها ألم بالمراق الأيمن ← التهاب كبد فيروسي ← يُطلب إجراء فحوص مخبرية لوظائف الكبد + إيكو بطن.

» وجدنا بإيكو البطن أن القناة الجامعة متوسعة (توسع قنوات صفراوية داخل الكبد)، ثم نقوم بإجراء رنين مغناطيسي للطرق الصفراوية MRCP.



هلال غازي أسفل الرئتين نتيجة انثقاب الغشاء

**حالة 2:** شخص مسن عمره 60 عام أتى بشكوى ألم، أثناء الفحص بالإيكو لوحظ وجود عدم تجانس على الكبد (بشكل بؤري) ← نشك بالانتقالات ← نجري طبقي محوري عديد الأطوار.

**حالة 3:** مريض لديه تخريش بريتوان (بطنه خشبية مع انحناء للأمام وألم بطني شديد وبطن غير متنفس)، يجب إجراء صورة بطن واقفاً لنرى وجود هلال غازي ← انثقاب حشا أجوف.

